

10 - 03-LEUCORRHEES - Pr. ABOULFALAH

Bonjour, ce cours sera consacré à la simbiologie des leucorrhées. Les leucorrhées, par définition, désignent un écoulement non sanglant qui provient des voies génitales féminines. Elles représentent un motif très fréquent de consultation, qu'elles soient en médecine générale ou en gynécologie.

Ces leucorrhées sont souvent physiologiques, mais parfois symptomatiques d'une infection, le plus souvent d'origine infectieuse. L'interrogatoire, l'examen clinique minutieux, permet d'orienter vers les étiologies. L'examen du rectoriologique au laboratoire n'est pas systématique.

Et on va voir les circonstances où on va être amené à demander cet examen-là. Bien évidemment, il faut chercher devant ces leucorrhées une infection sexuellement transmissible et chercher les causes favorisantes de ces infections. Et puis, il faut toujours penser au partenaire.

Je rappelle l'origine des leucorrhées physiologiques. C'est essentiellement d'origine cervicale, par la glaire cervicale sécrétée par l'endocolle et qui augmente surtout en période péri-ovulatoire. Et d'origine aussi vaginale, par la desquamation cellulaire.

La connaissance de l'écosystème vaginal est très, très importante. Il est dominé par une flore vaginale type bacille de Darleine, qui va être responsable d'un pH vaginal acide pour éviter les infections. Et bien évidemment, il faut connaître les facteurs qui influencent l'écosystème vaginal afin d'éviter les récives des infections.

La démarche diagnostique repose sur une anamnèse bien précise, un examen général, un examen gynécologique proprement parlé. Et en fonction de ces éléments-là, on peut être amené à demander un certain nombre d'examens complémentaires. L'interrogatoire va préciser l'identité de la patiente, son âge, le statut marital, ses antécédents.

Il va caractériser l'écoulement, en particulier la date d'apparition de l'écoulement, son mode d'évolution, la couleur de ses pertes, leur abondance et s'ils ont une odeur. L'interrogatoire va préciser les circonstances de survenue. Est-ce que ces pertes vaginales sont survenues après un rapport sexuel, et il faut penser là essentiellement aux infections sexuellement transmissibles, ou après un traitement antibiotique qu'il a, parce que les antibiotiques vont favoriser la survenue d'une mycose.

Lors d'une grossesse, c'est le choré peut-être d'origine physiologique, mais la grossesse favorise les mycoses. Est-ce que la patiente a eu le choré suite à un port de stérilet, et là il faut penser à l'infection en particulier l'endométrite et la salpergite. L'anamnèse s'attachera à rechercher un terrain favorisant, en particulier le diabète, la prise de corticoïdes, un terrain d'immunosuppression, et va rechercher aussi la notion d'infection sexuellement transmissible.

L'anamnèse va préciser les signes fonctionnels d'accompagnement. Est-ce qu'il y a un

brûlissement vulvaire, et dans ce cas-là on sera orienté vers une mycose. S'il présente des brûlures au niveau du vagin, on sera orienté beaucoup plus vers une menace.

Si c'est le corrécant mêlé avec le sang, il faut penser à une origine infectieuse, en particulier l'endométrite, mais c'est surtout les causes mycoplasmaïques. Il faut bien évidemment chercher s'il y a une douleur pélvienne, et là on sera orienté vers une infection génitale haute. Et puis, il faut demander et examiner le partenaire à la recherche d'une rougeur, brûlure, un incullement urethral ou une irritation.

L'examen général, il faut prendre la température, c'est très très important. Il faut faire une palpation abdominale, en particulier par le toucher vaginal associé au palpé abdominal. Et si l'utérus est douloureux, il faut penser à une infection génitale haute, et il faut faire aussi un examen complet, surtout des aires ganglionnaires.

L'examen gynécologique proprement parlé, on commence par une inspection de la région vulvo-périnéale à la recherche d'une irritation, d'une rougeur, des vésicules, une ulcération, une tuméfaction, et il faut rechercher des lésions de grattage. Il faut palper les glandes de Bartolin, les glandes para-urethrales et les glandes de Sken. Il faut voir le méa urethral s'il y a issue de pus.

Il faut faire un examen suspiculant afin de préciser l'aspect de ces leucorrhées, l'aspect de la muqueuse vaginale, voir l'état du col utérin, et parfois on peut être amené à faire des pré-dépandants bactériologiques et mycologiques. Le toucher vaginal associé au palpé abdominal à la recherche d'une infection génitale haute par la présence d'une sensibilité pelvienne ou carrément un empatement pelvien, les examens complémentaires ne sont pas systématiques, mais peut-être on peut être amené à faire un examen extemporané des leucorrhées au microscope. Donc on fait un étalement sur l'âme avec une goutte de sérum physiologique et on voit s'il y a des polynucléaires altérés, s'il y a des trichomonases, ou s'il y a des filaments mycéliens.

On peut être amené à faire un test à la potasse, ce qu'on appelle un sniff test, à la recherche d'une mycose ou des germes de type anaerobic et la vaginalise, caractéristiques par l'odeur de poisson pourri qu'il dégage. L'examen bactériologique au laboratoire se fait dans des indications précises. Quand il y a une infection génitale haute, quand il y a des leucorrhées qui récidivent, quand il y a une infection sexuellement transmissible ou une infection chez le partenaire.

Quand on suspect essentiellement une infection gonococcique, on fait un prélèvement du méa-orétral après un massage sous-orétral et puis on peut être amené, surtout dans le cadre des infections sexuellement transmissibles, à demander des sérologies, de la chivée, de la syphilis, des sérologies de chlamydie et des mycoplasmes. Et dans le cadre de ces infections sexuellement transmissibles, on peut être amené aussi à faire des prélèvements chez le partenaire. On peut être aussi demandé une numération de formules sanguines, CRP et un

examen cytotactériologique des urines parce qu'on peut avoir une infection urinaire associée.

Quelles sont les stéologies maintenant ? Il y a les leucorrhées physiologiques qui ont des caractéristiques bien spécifiques, on va les voir. Ces leucorrhées peuvent être d'origine infectieuse, soit des infections génitales basses, la vulve, vagin et exocolle, les infections génitales hautes, quand ça concerne l'endocolle, l'endomètre, l'endométrite ou l'annexe, en particulier les serpingites. Les leucorrhées peuvent être secondaires aussi à des myoplasies génitales ou à des corps étrangers.

Concernant les leucorrhées physiologiques, c'est très important de connaître leurs caractéristiques. Tout d'abord, elles sont témoins d'une bonne imprégnation oestrogénique. Leur aspect blanc-nacré ou opalescent, filon, est assez homogène.

En plus de cet aspect-là, on note l'absence de signes fonctionnels. Ça ne gratte pas, ça ne brûle pas et ça ne sente pas. C'est quelque chose de très important parce que ces leucorrhées physiologiques ne doivent pas être traitées, elles doivent être respectées.

En plus, elles n'ont pas d'odeur désagréable et à l'examen, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de signes locaux, ni au niveau de la vue, ni au niveau du vagin. Les leucorrhées infectieuses, dans la majorité des cas, sont d'origine mycosique, représentée essentiellement par le candida albicans. Comme c'est le cas dans cette image-là, on a des filaments mycéliens.

Le deuxième genre, c'est le trichomonas vaginalis. On le reconnaît très bien par son aspect microscopique. Il y a le gardelina vaginalis, ou la vaginose bactérienne.

Il y a le gonocoque, le mycoplasme, le chlamydiaire, et on peut trouver aussi des germes bails. En cas particulier, la femme enceinte, la grossesse favorise les mycoses. Chez la femme ménopausée, il faut toujours se méfier parce que ces leucorrhées peuvent être secondaires à une myoplasie.

Et puis, chez la jeune fille, il faut éliminer un corps étranger intravaginal ou une oxyrose. Donc, il faut faire une parazitologie de celles. En conclusion, la leucorrhée physiologique est l'expression d'une bonne imprégnation hormonale.

L'examen gynécologique permet d'orienter vers les principales physiologies infectieuses. En cas de leucorrhée, il faut penser aux infections sexuellement transmissibles. Et en cas de récidence, il faut penser aux facteurs favorisant et éventuellement les corriger, en particulier la grossesse, la contraception hormonale, les progestatifs.

Il faut penser aussi à l'hygiène intime de la femme et aussi penser aux partenaires. Chez la femme ménopausée, il ne faut pas oublier la possibilité de cancer génitaux. Et chez la jeune fille, il ne faut pas oublier la possibilité de corps étranger intravaginal.

Je vous remercie.

